

Storia della Follia

Salute Mentale · Sessione 02 · 25.02.2026

Questa lezione affronta la domanda che attraversa tutta la psichiatria: la follia è una malattia del cervello o il prodotto delle passioni e della vita? Un dibattito antico che non è mai finito — e che definisce ancora oggi come curiamo le persone.

I due sguardi fondamentali sulla follia

Il prof Pezzoli apre con una provocazione: la storia della follia non è la storia di un'unica idea che migliora nel tempo. **È la storia di due sguardi in perenne conflitto:**

- Lo sguardo **organicista (Gehirnpsychiatrie)**: la follia è una malattia del cervello, un danno biologico, un meccanismo rotto.
- Lo sguardo **psicologico/delle passioni (Geistespsychiatrie)**: la follia nasce dall'eccesso emotivo, dalle ferite della vita, dalla disregolazione delle relazioni e degli affetti.

Questi due filoni si sono alternati, scontrati e a volte integrati nei secoli. Il prof sottolinea che oggi non sono risolti: entrambi sono ancora vivi nei dibattiti clinici e negli approcci terapeutici.

Il racconto di Donizetti: due follie in una storia

Per rendere concreta la dialettica, il prof usa la figura di **Gaetano Donizetti (1797–1848)**, compositore d'opera.

La follia organica: Donizetti e la sifilide

Donizetti contrasse la **sifilide** in gioventù, descritta già da **Fracastoro (1476–1553)**. La sifilide ha tre fasi; l'ultima, dopo una latenza di 10–30 anni, attacca il sistema nervoso centrale provocando la **paralisi progressiva**: irritabilità, disturbi del linguaggio, deterioramento cognitivo irreversibile.

Fu **Bayle**, nei primi decenni dell'Ottocento, a ipotizzare il legame sifilide–follia. Solo nel **1913 Hideyo Noguchi** individuò il batterio *Treponema pallidum* nella corteccia cerebrale dei malati — prova biologica che quella follia era una malattia del cervello.

Nel 1847 Donizetti — ormai compromesso — fu internato con l'inganno nella casa di cura di Ivry-sur-Seine, fondata da Esquirol (allievo di Pinel). Poi riportato a Bergamo in carrozza attraverso il Reno, la Svizzera e il San Gottardo. I familiari gli facevano suonare le sue arie, ma nemmeno il tenore Rubini che gli cantò l'aria della *Lucia di Lammermoor* riuscì a "risvegliarlo". Donizetti morì nel 1848.

Questa è la follia **organica**: causata dal deterioramento del SNC, incomprensibile, inesorabile.

La follia delle passioni: Lucia di Lammermoor

La stessa opera racconta il secondo tipo di follia. Lucia è costretta dalla famiglia a sposare un uomo che non ama (la famiglia intercetta le sue lettere, fa credere che lui l'abbia abbandonata). La notte di nozze uccide il marito e ne esce in uno stato dissociativo: canta canzoni d'amore, è "altrove". Donizetti usa la **glassarmonica** per evocare musicalmente questa alterità — il suono del fantasma.

Questa è la follia **delle passioni**: ingiustizia, tradimento, costrizione — eccesso emotivo che travolge la ragione. Il prof sottolinea che questa follia ha una **quota di comprensibilità**: non condividiamo l'omicidio, ma capiamo la sofferenza che lo ha generato. Ci ritroviamo qualcosa.

"La follia di Lucia non è la follia che vive Donizetti nell'ultima fase della sifilide." — Pezzoli

Le due follie coesistono nella stessa storia: la malattia organica del compositore e la follia psicologica del personaggio che lui stesso aveva creato.

Percorso storico: dalle origini al Rinascimento

Grecia antica: la follia sacra e Ippocrate

In Grecia arcaica, la follia era interpretata come **possessione divina** o punizione degli dei. I luoghi di cura erano i templi sacri ad Asclepio, dio della medicina e fondatore degli Asclepidi — una sorta di "ordine dei medici" del V sec. a.C.

Ippocrate di Kos (~460–370 a.C.) fa il passo decisivo: emancipa la follia dalla magia. Dice che l'epilessia — il "male sacro" per eccellenza — ha la stessa natura di tutte le altre malattie. Niente più cause divine.

Introduce la **teoria degli umori**: quattro fluidi corporei il cui squilibrio genera malattia e carattere specifici. Pensala come quattro variabili di base di un sistema: se una va fuori controllo, tutto l'equilibrio crolla.

Umore	Elemento	Temperamento
Bile nera	Terra	Melanconico
Sangue	Aria	Sanguigno
Flegma	Acqua	Flemmatico
Bile gialla	Fuoco	Collerico

Chi segue questa teoria è detto **fluidista**. Il concetto di equilibrio come salute sopravvive fino a noi: il termine "squilibrato" viene direttamente da qui.

Empedocle (~490 a.C.) approfondisce: l'equilibrio si mantiene attraverso l'oscillazione tra poli contrari (caldo/freddo, umido/secco). Di qui il proverbio popolare della "doccia fredda" come rimedio ai bollori passionali — secoli di teoria medica condensati in un modo di dire.

Medioevo: pausa senza novità

Durante il Medioevo l'interpretazione della follia è mediata dalla religione. Non emerge nulla di genuinamente originale sul piano medico — solo compilazioni e antologie di testi antichi.

Rinascimento e 1500–1600: torna il corpo

Con la rinascita delle scienze nel 1500, si riprende la teoria degli umori, ma emergono anche nuove ipotesi di localizzazione cerebrale della follia:

- **Girolamo Mercuriale (1530–1606)**: studi sulla **catatonìa**
- **Johann Weyer (1515–1588)**: prima descrizione delle **allucinazioni visive**; ipotizza che le "streghe" usino erbe psicoattive — non demonologia, ma corpo come causa

Con il 1600 si afferma il concetto di "**Homme Machine**" (uomo macchina): l'uomo come organismo fisico, sganciato dalla dimensione teologica. Sfondo: Descartes.

De Lamettrie e il meccanicismo (1747)

Julien Offroy de Lamettrie pubblica nel 1747 *L'uomo macchina*, sviluppando la visione meccanicistica in modo definitivo:

"Una macchina complicatissima il cui meccanismo non può venire scoperto a priori bensì può venire gradatamente e pazientemente rilevato dagli studi di medicina." (Preti, 1955)

De Lamettrie riprende i fluidisti e descrive come gli umori influenzino personalità e malattia. Le sue intuizioni anticipano la psichiatria positivista dell'Ottocento.

I nervi entrano in scena (Settecento)

Accanto ai fluidi, nel Settecento compare un nuovo protagonista: i **nervi**. Filamenti e cavi dell'organismo, sensibili, soggetti a eccitamento:

- **Pomme** (1760): introduce il concetto di "attacchi di nervi", che arriverà fino a noi
 - **William Cullen** (1777): conia il termine **nevrosi**, raccogliendo isteria e ipocondria
 - **G.M. Beard** (1839–1883): **nevrastenia** — l'"esaurimento nervoso" popolare — il cervello come una batteria che si scarica sotto il peso della vita moderna
-

Pinel: la grande svolta (fine 1700)

Philippe Pinel (1745–1826) è la figura centrale della transizione. Famoso per aver liberato i folli dalle catene al Bicêtre (1793) — gesto diventato quasi mitologico, ma il prof nota che la vera rivoluzione è concettuale.

Pinel cambia paradigma: la follia non è (o non è sempre) una malattia del cervello. Per la maggior parte dei casi la causa è nelle **passioni e nella vita morale** della persona. E se è così, la follia può essere guarita.

"L'alienazione non implica affatto la lesione organica del sistema nervoso ma soltanto l'alterazione delle sue funzioni." (Galzigna, 1992, p. 135)

I quattro principi di Pinel

Il prof li elenca come fondamentali ancora oggi:

1. **Guaribilità** — la follia da passioni è guaribile. L'ospedale è un luogo di passaggio, non di internamento definitivo.
2. **Principio patoplastico** (anche detto autoplastico) — la malattia si imprime su un substrato unico. Due persone con la stessa diagnosi possono esprimere la

malattia in modo completamente diverso. Esempio: due pazienti con allucinazioni — uno vede un angelo, l'altro un diavolo. Stessa allucinazione, due mondi diversi.

3. Principio di parzialità della follia — anche il "folle" conserva sempre una parte sana, ancora interlocutrice. Non ha senso attaccare frontalmente il delirio — lo si perde. Bisogna rivolgersi alla parte non malata. È come trovare in un sistema guasto il modulo che risponde ancora: non si resetta tutto, si cerca l'ingresso funzionante.

4. Trattamento morale (*traitement moral*) — la cura avviene attraverso la relazione, l'ascolto, il riordino della vita emotiva. Le passioni che hanno trascinato la ragione si regolano attraverso nuove esperienze relazionali.

Il prof segnala anche la **deriva paternalistica**: Pinel metteva in scena "finte commissioni statali" per curare pazienti con deliri persecutori — manipolazione non accettabile oggi, ma nel contesto storico era un passo avanti rispetto all'internamento coercitivo.

La storia del paziente: elemento centrale

Il prof collega Pinel a Donizetti: cantare al compositore le sue arie era un tentativo di raggiungerlo nel suo "altrove". **Principio: per curare qualcuno devi conoscerne la storia, i gusti, le relazioni, le persone che amava.**

"La cura va personalizzata." — Pezzoli

Esquirol: la differenziazione (inizio 1800)

Jean-Étienne Esquirol (1772–1840), allievo e continuatore di Pinel, struttura meglio la distinzione:

- **Follia da passioni** (tipo Lucia): comprensibile, trattabile con il metodo morale, potenzialmente guaribile
- **Follia organica** (tipo Donizetti): paradigma dell'incurabilità — demenza e paralisi progressiva

Esquirol distingue anche tra: - **Idiozia**: condizione di nascita (mancato sviluppo delle facoltà intellettuali) — esclusa dal campo delle malattie - **Demenza**: deterioramento acquisito che insorge nella vita (pubertà o come esito di malattia)

Importante: per Pinel ed Esquirol **l'ascolto del malato è fondamentale**. I sintomi (ciò che il paziente dice di vivere) prevalgono sui segni (ciò che il medico osserva dall'esterno). Questo cambierà radicalmente con il positivismo.

Il positivismo: il trionfo dell'organicismo (XIX sec.)

Con la seconda metà dell'Ottocento, il pendolo oscilla pesantemente verso il polo organicista. La psichiatria vuole diventare scienza esatta, come la medicina del corpo.

Wilhelm Griesinger (1817–1868) lancia il motto-simbolo:

"Le malattie psichiche sono malattie del cervello" (die psychischen Krankheiten sind Erkrankungen des Gehirns)

Introduce la distinzione tra **Somatiker** (medici organicisti) e **Psychiker** (chi attribuisce la follia a cause psicologiche).

Morel e la teoria della degenerazione

Benedict Augustin Morel (1809–1873) introduce il concetto di **degenerazione**: sull'onda del darwinismo (*Origine della specie*, 1859), legge la follia come involuzione evolutiva — la perdita delle conquiste che la specie aveva faticosamente guadagnato.

Il percorso della degenerazione inizia con il **delirio** — e il prof spiega la struttura logica del delirio con il sillogismo:

- Premessa universale vera → conclusione corretta = pensiero sano
- **Premessa non universale + autoriferimento = delirio**

Esempio: "Lui tossisce → lui mi sfotte." La deduzione ha una logica interna, ma la premessa non è universale. È lì che salta il ragionamento — il pensiero è "di fianco" alla realtà. Da qui: *paranoia* (greco: *parà* = di fianco + *noos* = pensiero).

Per Morel la degenerazione è **progressiva e irreversibile**. Nasce qui il concetto di **demenza precoce**: la patologia si sviluppa in giovane età e porta al deterioramento cognitivo definitivo.

Lombroso e l'antropologia criminale

Cesare Lombroso (1835–1909) è la figura-simbolo del positivismo italiano. Misurava tutto: crani, tatuaggi, anomalie morfologiche. La sua teoria dell'**atavismo**: alcune anomalie corporee riavvicinano l'individuo ai primati — segnale di regresso evolutivo iscritto nel corpo.

La Pellagra: quando la povertà fa impazzire

Il manuale riporta l'esempio della **pellagra** come paradigma di causa organica-esogena che produce sintomi psichici.

La pellagra è la malattia delle **3 D: Dermatosi, Diarrea, Demenza**. In inglese si aggiunge una quarta D: *Death*.

Causa identificata: **monofagismo maidico** — dieta quasi esclusiva di mais in comunità povere (soprattutto campagne del nord Italia nell'Ottocento) con conseguente **carenza di niacina** (vitamina B3 / aminoacido essenziale).

Il prof sottolinea che gli organicisti, cercando la causa biologica della follia, paradossalmente **denunciavano la povertà** come fattore causale — un risultato politicamente interessante, anche se ottenuto con metodo riduzionista.

Kraepelin: la mappa nosologica (fine XIX sec.)

Emil Kraepelin (1856–1926) costruisce la prima grande classificazione moderna delle malattie mentali — la base sulla quale è costruito ancora oggi il DSM.

Per Kraepelin i sintomi non vanno ascoltati ma classificati: sono **segni** di un sistema biologico che malfunziona. L'attenzione alla parola del paziente (cara a Pinel ed Esquirol) è praticamente archiviata.

Classifica le malattie in due grandi famiglie:

Malattie esogene (cause esterne): - *Psicologiche*: traumi, eventi di vita - *Somatiche*: infezioni, carenze nutrizionali, agenti biologici

Malattie endogene (prodotte dall'interno del SNC):

Patologia	Asse compromesso	Decorso
Psicosi maniaco-depressiva	Asse emotivo	Parzialmente reversibile
Demenza precoce	Unità interna	Progressiva, irreversibile

Bleuler: la sintesi tra organico e psicologico (1911)

Eugen Bleuler (1857–1939) — i cui assistenti includevano Carl Gustav Jung ed Eugène Minkowski — tenta una sintesi tra i due sguardi.

Nel 1911 rinomina la demenza precoce **schizofrenia** e distingue:

- **Sintomi primari** (fondamentali): conseguenza diretta del danno cerebrale; subiti passivamente dal paziente; base della diagnosi
- **Sintomi secondari** (accessori): reazione psicologica del soggetto alla sofferenza di fondo; variabili da persona a persona perché dipendono dalla soggettività di ciascuno

Recupera il principio **patoplastico** di Pinel: la malattia si esprime in modo unico su ogni persona. Il paziente non è solo il suo danno cerebrale — è anche chi reagisce a quel danno con la sua storia e la sua soggettività.

La dimensione identitaria della malattia mentale

Il prof introduce tre dimensioni che la malattia mentale mette in crisi nel soggetto:

1. **Identità** (chi sono?)
2. **Spazialità** (dove sono? essere "altrove")
3. **Temporalità** (in che tempo vivo?)

Il vocabolario popolare della follia è quasi tutto spaziale: "fuori di testa", "spostato", "fuori come un balcone" — linguaggio che parla di un altrove rispetto alla norma condivisa.

Il prof sottolinea una differenza linguistica fondamentale: - **Avere** una malattia → non identificazione con essa - **Essere** una malattia → identificazione identitaria

Le malattie psichiche tendono a usare l'ausiliare essere: "sono schizofrenico" più che "ho la schizofrenia". Questo non è neutro — implica due paradigmi di cura molto diversi.

Il punto di arrivo: Cargnello e l'ambiguità irriducibile

Danilo Cargnello formula la sfida fondamentale di chi lavora con la sofferenza mentale:

"Il sapersi mantenere con l'altro e non semplicemente di fronte all'altro — anche se quest'altro è uno psicotico che per natura sembrerebbe sottrarsi all'offerta di coesistenza — è un compito straordinariamente difficile." (Cargnello, 1999)

L'ambiguità della psichiatria: oscillare tra "**essere con qualcuno**" e "**avere qualcosa di fronte.**" Il rischio del polo organicista è ridurre la persona a un cervello malfunzionante. Il rischio del polo psicologista è perdere di vista la dimensione biologica. La clinica — l'incontro reale — è il terreno dove questa tensione va abitata, non risolta.

Concetti chiave

Termine	Significato
Gehirnpsychiatrie	Psichiatria del cervello: follia come malattia organica
Geistespsychiatrie	Psichiatria della mente: follia come prodotto psicologico/sociale
Somatiker	Medici organicisti (seguaci di Griesinger)
Psychiker	Medici che attribuiscono la follia a cause psicologiche
Teoria degli umori	4 fluidi corporei (Ippocrate); squilibrio = malattia
Fluidisti	Seguaci della teoria degli umori
Nevrosi	Termine di Cullen (1777): raggruppa isteria, ipocondria e simili
Nevrastenia	"Esaurimento nervoso" (Beard): cervello come batteria scaricabile
Trattamento morale	Cura via relazione, ascolto e riordino emotivo (Pinel)
Patoplastica	La stessa malattia si esprime in modo unico su ogni persona
Parzialità della follia	Nel malato c'è sempre una parte sana — ci si rivolge a quella
Guaribilità	La follia da passioni è curabile (Pinel)
Degenerazione	Morel: follia come involuzione evolutiva, progressiva e irreversibile
Delirio paranoico	Ragionamento su premesse non universali + autoriferimento

Termine	Significato
Paranoia	Dal greco <i>parà</i> (di fianco) + <i>noos</i> (pensiero): pensiero parallelo
Demenza precoce	Kraepelin: patologia endogena; Bleuler la rinomina schizofrenia (1911)
Schizofrenia	Termine di Bleuler (1911): perdita dell'unità interna del soggetto
Psicosi maniaco-depressiva	Patologia endogena: oscillazione maniacale ↔ depressiva
Alienazione	Uscire dal proprio mondo — essere "altrove"
Comprensibilità (Jaspers)	Follia passionale = comprensibile; follia organica = no
Pellagra	Malattia da carenza di niacina (monofagismo maidico): 3 D
Atavismo	Lombroso: anomalie corporee come segni di regresso evolutivo

Domande di orientamento allo studio

Descrivi il percorso dell'approccio alla malattia mentale dall'antichità alla modernità, tra malattia del corpo e malattia della psiche.

Dalla Grecia arcaica, dove la follia era interpretata come possessione divina o punizione degli dei, Ippocrate (~460 a.C.) compie il salto decisivo emancipandola dalla religione: introduce la teoria degli umori (squilibrio di quattro fluidi corporei come causa di malattia). Nel Medioevo non emergono novità originali — domina l'interpretazione religiosa. Con il Rinascimento torna l'interesse per il corpo: Mercuriale studia la catatonia, Weyer descrive le allucinazioni visive. Il Seicento introduce l'«Homme Machine» (Descartes, poi De Lamettrie nel 1747): l'uomo come organismo fisico. Nel Settecento i nervi diventano protagonisti (Cullen conia

"nevrosi" nel 1777, Beard introduce la "nevrastenia"). Fine Settecento: Pinel capovolge il paradigma — la follia nasce spesso dalle passioni, è guaribile con il trattamento morale. Ottocento positivista: Griesinger afferma che le malattie psichiche sono malattie del cervello; Morel introduce la degenerazione; Kraepelin costruisce la prima grande nosologia. Bleuler (1911) tenta una sintesi, rinominando la demenza precoce "schizofrenia" e distinguendo sintomi primari (organici) e secondari (psicologici).

Qual è il contributo di Pinel alla psichiatria e quali spunti offre per il lavoro sociale?

Pinel (1745–1826) è la figura centrale della transizione: nel 1793 libera i folli dalle catene al Bicêtre (gesto simbolico), ma la sua vera rivoluzione è concettuale. Sostiene che per la maggior parte dei casi la follia non è malattia del cervello ma effetto delle passioni e della vita morale — e quindi è guaribile. Per il lavoro sociale, i suoi quattro principi sono ancora vivi: la **guaribilità** (l'ospedale è un luogo di passaggio, non di internamento definitivo); la **patoplastica** (la stessa malattia si esprime in modo unico su ogni persona — bisogna trattare l'individuo, non la diagnosi); la **parzialità della follia** (c'è sempre una parte sana a cui rivolgersi — non si attacca il delirio frontalmente); il **trattamento morale** (la cura avviene attraverso la relazione, l'ascolto, il riordino della vita emotiva). In sintesi: conoscere la storia del paziente è preconditione della cura.

Qual è il presupposto innovativo di Pinel nell'approccio al malato mentale?

Il presupposto innovativo di Pinel è che la follia da passioni è guaribile e che il malato non è mai interamente alienato. Anche il "folle" conserva sempre una parte sana — e su quella va lavorare. Di conseguenza la relazione terapeutica diventa il cuore della cura: la storia del paziente, le sue passioni, i suoi affetti non sono dati irrilevanti ma la materia stessa del trattamento. Questo è in netta rottura con il modello organicista, dove il paziente è un meccanismo rotto da osservare dall'esterno.

Qual è lo scopo delle case di trattamento (asylum) e la loro funzione storica?

Le case di cura nate sull'onda di Pinel (come quella di Ivry-sur-Seine fondata da Esquirol) nascono con una vocazione terapeutica: non sono luoghi di reclusione permanente ma di passaggio e guarigione. Il trattamento morale richiede un ambiente controllato, lontano dalle stimolazioni che hanno generato la follia, dove la relazione medico-paziente possa dispiegarsi. Con il positivismo di fine Ottocento, però, la funzione terapeutica lascia sempre più spazio a quella classificatoria e custodiale — il manicomio diventa archivio di incurabili più che luogo di cura.

Da dove origina la follia per Pinel e quali sono le sue caratteristiche?

Per Pinel la follia ha nella maggior parte dei casi un'origine passionale: eccessi emotivi, ferite relazionali, eventi traumatici della vita morale. Questo tipo di follia ha due caratteristiche fondamentali: è comprensibile (si può riconoscere nell'esperienza della sofferenza umana) ed è guaribile (può essere affrontata con il trattamento morale). Si distingue nettamente dalla follia organica — come quella di Donizetti causata dalla sifilide terziaria — che è incomprensibile, inesorabile, e non risponde al trattamento relazionale.

Quali sono i mezzi e i principi del trattamento morale (traitement moral) di Pinel?

Il trattamento morale agisce attraverso la relazione, l'ascolto e il riordino della vita emotiva. I suoi principi operativi sono quattro: guaribilità (la follia da passioni si cura), patoplastica (la cura va personalizzata), parzialità della follia (la parte sana è l'interlocutore privilegiato — non si attacca il delirio frontalmente) e trattamento morale in senso stretto (le passioni che hanno travolto la ragione si regolano attraverso nuove esperienze relazionali controllate). In pratica: conoscere i gusti, la storia, le relazioni del paziente non è anamnesi accessoria — è preconditione della cura.

Qual è il contributo dell'Ottocento e del positivismo allo studio della malattia mentale?

Il positivismo vuole rendere la psichiatria una scienza esatta. Griesinger (1817–1868) lancia il motto «le malattie psichiche sono malattie del cervello», polarizzando il campo tra Somatiker (organicisti) e Psychiker (psicologisti). Morel (1809–1873) introduce la teoria della degenerazione: sull'onda di Darwin, la follia è

involuzione evolutiva, progressiva e irreversibile. Lombroso porta il riduzionismo al corpo: misura crani, identifica "stigmati" atavistiche. Il contributo più duraturo, però, è quello di Kraepelin, che costruisce la prima grande mappa nosologica delle malattie mentali — la base del DSM attuale.

Qual è l'innovazione di Kraepelin e la sua concezione della malattia mentale?

Kraepelin (1856–1926) costruisce la prima classificazione sistematica delle malattie mentali. La sua concezione è rigorosamente organicista: i sintomi non vanno ascoltati ma classificati come segni di un sistema biologico che malfunziona. Divide le malattie in esogene (da cause esterne: psicologiche come i traumi, o somatiche come infezioni e carenze) ed endogene (prodotte dall'interno del SNC). Tra le endogene distingue due grandi entità: la psicosi maniaco-depressiva (sull'asse emotivo, parzialmente reversibile) e la demenza precoce (sull'asse dell'unità interna del soggetto, progressiva e irreversibile — poi rinominata schizofrenia da Bleuler nel 1911).

Quale atteggiamento propone Kraepelin verso il sintomo psichico?

Per Kraepelin il sintomo psichico non va ascoltato ma classificato. È un **segno** di un malfunzionamento biologico, non un messaggio portatore di senso soggettivo. Questo rovescia completamente l'approccio di Pinel ed Esquirol, per cui i sintomi — ciò che il paziente dice di vivere — avevano valore diagnostico e terapeutico. Con Kraepelin la parola del paziente diventa irrilevante rispetto all'osservazione clinica esterna.

Come suddivide Kraepelin le malattie mentali?

In due grandi classi: **esogene** (da cause esterne) e **endogene** (da cause interne al SNC). Le malattie esogene si dividono in psicologiche (traumi, eventi di vita) e somatiche (infezioni, carenze nutrizionali come nella pellagra, agenti biologici come la sifilide). Le endogene hanno due grandi entità: la psicosi maniaco-depressiva (asse emotivo, decorso parzialmente reversibile con oscillazioni tra polo maniacale e depressivo) e la demenza precoce (asse dell'unità interna, decorso progressivo e irreversibile, con deterioramento cognitivo definitivo).

Cos'è il "pendolo timico" e come si collega alla teoria degli umori?

Il "pendolo timico" è la metafora che descrive l'oscillazione della psicosi maniaco-depressiva tra il polo maniacale (ideazione accelerata, ipermotilità, attenzione dispersa) e il polo depressivo (ideazione povera, rallentamento, immobilità). Il legame con la teoria degli umori di Ippocrate è esplicito: il bile nera (melancholia) era già nella tradizione ippocratica la causa della depressione, il sangue quella dell'eccitamento. Kraepelin riprende, con linguaggio positivista, una struttura concettuale vecchia di duemila anni: l'asse emotivo come sistema in equilibrio dinamico che può squilibrarsi in entrambe le direzioni.

Domande esame 02

(Estratte da risorse/domande_esame_02.txt)

Definizione del percorso dell'approccio alla malattia mentale dall'antichità alla modernità tra malattia del corpo e malattia della psiche.

Vedi risposta sopra: "Descrivi il percorso..."

Il contributo di Pinel nel panorama della psichiatria e gli spunti per il lavoro sociale.

Vedi risposta sopra: "Qual è il contributo di Pinel..."

Quale è il presupposto innovativo all'approccio al malato mentale di Pinel?

Vedi risposta sopra: "Qual è il presupposto innovativo..."

Scopo delle case di trattamento e loro funzione.

Vedi risposta sopra: "Qual è lo scopo delle case di trattamento..."

Da dove origina follia per Pinel e quali sono le caratteristiche?

Vedi risposta sopra: "Da dove origina la follia per Pinel..."

Quali sono i mezzi e i principi del trattamento morale?

Vedi risposta sopra: "Quali sono i mezzi e i principi..."

Il contributo Ottocentesco e del Positivismo allo studio e all'approccio della malattia mentale.

Vedi risposta sopra: "Qual è il contributo dell'Ottocento e del positivismo..."

La figura e l'innovazione di E. Kraepelin e concezione della malattia mentale.

Vedi risposta sopra: "Qual è l'innovazione di Kraepelin..."

Quale atteggiamento propone E. Kraepelin verso il sintomo psichico?

Vedi risposta sopra: "Quale atteggiamento propone Kraepelin..."

Come suddivide E. Kraepelin le malattie mentali?

Vedi risposta sopra: "Come suddivide Kraepelin..."

Il pendolo timico e la teoria degli umori.

Vedi risposta sopra: "Cos'è il 'pendolo timico'..."

Collegamenti

- **Lezione 03 (Empatie):** il principio di parzialità di Pinel — rivolgersi alla parte sana — ricompare nella capacità empatica di stare accanto senza sostituirsi
- **Lezione precedente (01):** introduzione alla malattia mentale come condizione che mette in crisi identità, spazialità e temporalità
- **Temî aperti:** dibattito attuale tra neurobiologia e psicoterapia relazionale — il "pendolo" Gehirnpsychiatrie/Geistespsychiatrie non si è fermato